第十九章 慢性阻塞性肺疾病的全科医学处理

本章数字资源

学习提要

- 慢性阻塞性肺疾病是成人患病和死亡的主要原因，也是社区医疗最常见的就诊原因之一。
- 掌握慢性阻塞性肺疾病的临床特征有助于全科医生进行正确的诊断和处理。
- 对于慢性阻塞性肺疾病，全科医生应对患者进行随访、复查和提供康复指导。
- 全科医生需要了解慢性阻塞性肺疾病的流行病学特征，熟悉其常见危险因素，并通过健康教育、早期筛查等有效手段实施人群保护，以预防疾病发生。

慢性阻塞性肺疾病（chronic obstructive pulmonary disease，COPD）简称慢阻肺病，是最常见的慢性气道疾病，也是“健康中国 2030”行动计划中重点防治的疾病。2018 年“中国成人肺部健康研究”调查结果显示，我国 20 岁及以上成人慢阻肺病患病率为 8.6%，40 岁以上人群患病率高达 13.7%，估算我国慢阻肺病患者数近 1 亿人。根据全国疾病负担调查，慢阻肺病是我国 2016 年第 5 大死亡原因。慢阻肺病具有高患病率、高死亡率、高病死率、高疾病负担的特点，已经成为同高血压、糖尿病等量齐观的慢性疾病。基层医疗卫生机构作为管理慢性疾病的第一道防线，全科医生在管理慢阻肺病上具有不可忽视的作用。

临床病例

主观资料（S）：患者，男性，79 岁，因“反复咳嗽、咳痰、气喘 10 年，加重 7 天”至全科医学门诊就诊。

【问题 1】根据患者的主诉症状，在病史询问环节，全科医生应从哪些环节来了解患者的病情？

思路 1：询问患者主要的症状和不适感，如咳嗽、咳痰、气短、胸闷等，以及症状出现的频率、持续时间、对日常生活的影响程度、近期症状有无加重及诱因。

思路 2：了解患者目前是否有其他疾病，特别是与呼吸困难相关的疾病，如支气管哮喘、慢性支气管炎、心脏病史等。

思路 3：询问患者是否有吸烟史、长期接触有害气体或粉尘的工作史，以及家族中是否有慢阻肺病或其他呼吸系统疾病的病史。

知识点

慢阻肺病是一种常见的、可以预防和治疗的疾病，以持续性呼吸道症状和气流受限为特征，通常是由明显暴露于有毒颗粒或气体引起的气道和/或肺泡异常所导致。慢性气流受限是慢阻肺病的特征，由小气道疾病（阻塞性支气管炎）和肺实质破坏（肺气肿）共同引起，二者在不同患者所占比重不同。这些变化并不总是同时出现，但随时间以不同的速度进展。急性加重和并发症影响着疾病的严重程度。

一、慢阻肺病的症状

慢阻肺病起病缓慢，病程较长。主要有以下症状。

（一）慢性咳嗽

随病程发展可终身不愈。常晨间咳嗽明显，夜间有咳嗽或排痰。有少数病例虽有明显气流受限，却无咳嗽症状。

（二）咳痰

一般为白色黏液或浆液性泡沫痰，偶可带血丝，清晨排痰较多。急性发作期痰量增多，可有脓性痰。

（三）气短或呼吸困难

气短或呼吸困难是慢阻肺病的标志性症状，最初仅在劳动、上楼或爬坡时有气促，休息后气促可以缓解。随着病变的发展，在平地活动时也可以出现气促。晚期患者进行穿衣、洗漱、进食等日常生活活动时即可发生气促，甚至在静息时也感气促。急性加重期支气管分泌物增多，通气功能障碍加重，使胸闷、气促加重。

（四）喘息和胸闷

部分患者特别是重度或急性加重期患者可出现喘息和胸闷。

（五）其他

晚期患者有体重下降，食欲减退、营养不良等表现。

二、慢阻肺病的危险因素

了解慢阻肺病的危险因素，可以让全科医生更有针对性地进行疾病的筛查，并在慢阻肺病长期管理过程中，对生活方式进行干预，以延缓疾病的发生发展。目前已经发现的危险因素可以分为外因与内因两类。

（一）外因

慢阻肺病危险因素中的外因主要指环境因素。

1. 吸烟　是目前公认的慢阻肺病已知风险因素中最重要者。吸烟人群同不吸烟人群相比，肺功能异常发生率明显升高，出现呼吸道症状的人数明显增多，肺功能检查中反映气道是否有阻塞的核心指标第 1 秒用力呼气容积（FEV_1）下降幅度更快。已经患有慢阻肺病者，吸烟患者的病死率明显高于不吸烟患者。

2. 室内空气污染　可由在通风差的住所燃烧生物燃料烹饪和取暖造成。

3. 室外大气污染　增加肺吸入的颗粒总量，同时会加重慢阻肺病患者病情。

4. 职业暴露　有机和无机粉尘、化学物质和废气的吸入都会促使慢阻肺病发病。

5. 社会经济地位　社会经济地位较低的人群发生慢阻肺病的概率较大，可能与室内外空气污染、居室拥挤、缺乏营养、感染或其他与社会经济地位较低相关联的因素有关。

（二）内因

慢阻肺病危险因素中的内因主要指个体易患因素。

1. 遗传因素　流行病学研究显示慢阻肺病易患性与基因相关，并涉及多个基因。遗传性 α_1-抗胰蛋白酶缺乏症（AATD）为典型代表，但国内尚未发现病例。

2. 肺生长与发育　任何在孕期和儿童期影响肺生长的因素都可能增加个体慢阻肺病的发生风险。如：低出生体重、呼吸道感染等。

3. 哮喘和气道高反应性　哮喘及气道反应性增高者，慢阻肺病发病率也明显增高。

4. 慢性支气管炎　会增加总体发作频率和重度急性加重发作频率。

5. 感染　已有研究发现，儿童期重度呼吸道感染病史与成人期肺功能下降及呼吸道症状增加相关。对于已经患有慢阻肺病者，呼吸道感染是导致疾病急性发作的一个重要因素，可以加剧病情进展。

三、慢阻肺病的分期

慢阻肺病的稳定期主要指患者的咳嗽、咳痰和气短等症状稳定或症状轻微的状态。

慢阻肺病急性加重期是慢阻肺病一种急性的起病过程，患者呼吸道症状超过日常变异范围，持续恶化，并且须改变药物治疗方案。在这一过程中，患者常有短期内咳嗽、咳痰、气短和/或喘息加重，痰量增多，脓性或者黏液脓性痰，可伴有发热等炎症明显加重的表现。

临床病例（续）

主观资料（S）：患者近 10 年来反复于受凉、劳累后出现咳嗽、咳痰，为白色黏痰，每年持续 3 个月以上，多次于当地医院就诊，诊断为“慢性支气管炎”，给予抗感染、化痰、平喘等治疗后好转。7 天前受凉后出现咳嗽、咳黏痰，同时自觉气促，活动后明显。伴食欲减退、乏力。自服阿莫西林治疗，未见明显好转。

患者既往有高血压病史 20 年，口服硝苯地平缓释片治疗，血压控制较好。否认冠心病、糖尿病病史，否认结核、哮喘病史。吸烟 50 年，每日 30 支。否认饮酒史。

【问题 2】根据患者的主观资料，在体格检查时要注意哪些方面的体征？

思路 1：一般查体包括体温、脉搏、呼吸频率、血压、血氧饱和度等。

思路 2：重点检查注意是否有口唇发绀，颈静脉充盈，桶状胸，肝浊音界下降，心浊音界缩小，肺部异常呼吸音及干、湿啰音，下肢有无水肿等。

知识点

慢性阻塞性肺疾病的常见体征

慢阻肺病患者早期体征可无异常，随疾病进展可出现阻塞性肺气肿的体征。

（一）视诊

桶状胸：胸廓前后径增大，肋间隙增宽，剑突胸骨下角增宽。部分患者呼吸变浅，频率增快，严重者可有缩唇呼吸等。

（二）触诊

双侧语颤减弱。并发早期肺心病的患者可触及剑突下心脏搏动。

（三）叩诊

肺部叩诊过清音，心浊音界缩小，肺下界和肝浊音界下降。

（四）听诊

两肺呼吸音减弱，呼气期延长常提示有气道阻塞和气流受限，与肺功能检测结果有相关性。部分患者可闻及湿啰音和/或干啰音。合并哮喘者可闻及哮鸣音。剑突下心音较心尖明显增强可提示早期肺心病。

【问题 3】为进一步了解病情，还需要做哪些方面的实验室检查？

思路 1：肺功能检查：进行肺功能检查是确诊慢阻肺病的关键步骤。常见的肺功能检查包括肺活量测定、FEV_1（第 1 秒用力呼气容积）测定、FEV_1/FVC（第 1 秒用力呼气容积与用力肺活量之比）测定等。

思路 2：胸部 X 线检查有助于了解肺部结构，排除其他疾病的可能性。

知识点

肺功能检查是慢阻肺病诊断的“金标准”，是慢阻肺病的严重程度评价、疾病进展监测、预后及治疗反应评估中最常用的指标。气流受限是以 FEV_1 占用力肺活量（forced vital capacity，FVC）百分比（FEV_1/FVC）和 FEV_1 占预计值百分比降低来确定的。应用支气管扩张剂后，$FEV_1/FVC<70\%$ 可确定存在持续性气流受限，除外其他疾病后可确诊慢阻肺病。

胸部 X 线检查对确定肺部并发症及与其他疾病（如肺间质纤维化、肺结核等）鉴别具有重要意义。慢阻肺病早期 X 线胸片可无明显变化，之后出现肺纹理增多和紊乱等非特征性改变；主要 X 线征象为肺过度充气等。其他可在基层开展的检查还包括血氧饱和度（SaO_2）、血常规、心电图。

对确定发生低氧血症、高碳酸血症、酸碱失衡以及判断呼吸衰竭的类型有重要价值。

COPD 合并细菌感染时，外周血白细胞增高，核左移。痰培养可能查出病原菌；常见病原菌为肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、肺炎克雷伯菌等。

临床病例（续）

客观资料（O）

体格检查：体温 36.4℃，脉搏 80 次/分，呼吸 20 次/分，血压 130/82mmHg，口唇无发绀，球结膜无水肿，颈静脉无怒张，双侧胸廓对称，胸廓前后径增大，肋间隙增宽，剑突胸骨下角增宽。呼吸活动度双侧对称，双侧触觉语颤对称，未触及胸膜摩擦感。双肺叩诊清音，双肺呼吸音减弱，双肺散在呼气相哮鸣音，呼气相延长，未闻及湿啰音。心界不大，心律齐，心率 80 次/分，无杂音。腹软，无压痛、反跳痛。双下肢无水肿。

肺功能检查：患者在社区行肺功能检查，吸入支气管扩张剂后 FEV_1/FVC 为 56%，FEV_1 占预计值百分比为 49.9%。胸部 X 线检查示胸腔前后径增加，肋骨走向变平，肺野透亮度增高。

【问题 4】慢阻肺病需要同哪些疾病进行鉴别？

思路：慢阻肺病应与哮喘、支气管扩张症、充血性心力衰竭、肺结核和弥漫性泛细支气管炎等疾病进行鉴别。

知识点

慢阻肺病的患者可能会存在长期咳嗽，因此要和能够引起长期咳嗽的一些疾病相鉴别，比如肺结核、肺间质纤维化、风湿性心脏病等；慢阻肺病还需要和能够引起呼吸困难的一些疾病相鉴别，比如支气管哮喘、心功能不全等。鉴别要点见表 19-1。

表 19-1 慢阻肺病与其他疾病的鉴别诊断要点

疾病	鉴别诊断要点
慢性阻塞性肺疾病	中老年发病，症状缓慢进展，长期吸烟史或者其他烟雾接触史
哮喘	早年发病（通常在儿童期），每日症状变化快，夜间和清晨症状明显，也可有过敏史、鼻炎和/或湿疹、哮喘家族史
充血性心力衰竭	X 线胸片示心脏扩大、肺水肿，肺功能提示有限制性通气功能障碍，而非气流受限
支气管扩张症	大量脓痰，常伴有细菌感染、粗湿啰音、杵状指，X 线胸片或 CT 提示支气管扩张、管壁增厚

续表

疾病	鉴别诊断要点
肺结核	所有年龄均可发病，X 线胸片示肺浸润性病灶或者结节状、空洞样改变，微生物检查可确诊，流行地区高发
闭塞性细支气管炎	发病年龄较轻，不吸烟，可能有类风湿关节炎病史或者烟雾接触史，呼气相 CT 显示低密度影
弥漫性泛细支气管炎	主要发生在亚洲人群中，多为男性非吸烟者，几乎均有慢性鼻窦炎，X 线胸片和高分辨率 CT 示弥漫性小叶中央结节影和过度充气征

【问题 5】如何对该患者目前病情进行评估？

思路：慢阻肺病评估目标是明确气流受限的严重程度，对健康状况和未来事件（如急性加重、住院或死亡）发生风险的影响，最终目的是指导治疗。应综合评价肺功能异常是否存在及严重程度、目前症状的性质和程度、急性加重病史和未来发生风险、合并症，以期改善慢阻肺病的疾病管理。全科医生在对慢阻肺病进行管理的过程中，应针对不同需求，对患者进行各个层面的评估。

知识点

（一）气流受限程度分级

为简明起见，慢阻肺病全球倡议指南（GOLD 指南）中推荐使用肺功能界值来明确气流受限的程度。在给予至少一种足量的短效支气管扩张剂后进行肺功能检查，以减少变异性（表 19-2）。

表 19-2　使用肺功能检查评估气流受限严重程度

COPD 患者气流受限严重程度分级		以吸入支气管扩张剂后 FEV_1 值为基础，$FEV_1/FVC<70\%$
GOLD 1 级	轻度	FEV_1 占预测值的百分比≥80%
GOLD 2 级	中度	50%≤FEV_1 占预测值的百分比 <80%
GOLD 3 级	重度	30%≤FEV_1 占预测值的百分比 <50%
GOLD 4 级	极重度	FEV_1 占预测值的百分比 <30%

（二）症状评估

采用改良版英国医学研究委员会呼吸困难问卷（mMRC 问卷）（表 19-3）对呼吸困难程度进行评估，慢阻肺病患者自我评估测试问卷（CAT 问卷）（表 19-4）对呼吸系统症状及全身症状进行了分级评估。mMRC 问卷仅反映呼吸困难程度。CAT 问卷为综合症状评分，分值范围为 0~40 分（0~10 分：轻微影响；11~20 分：中等影响；21~30 分：严重影响；31~40 分：非常严重影响）。10 分及以上为症状多。

表 19-3　改良版英国医学研究委员会呼吸困难问卷

呼吸困难评价等级	呼吸困难严重程度
0 级	只有在剧烈活动时感到呼吸困难
1 级	在平地快步行走或者步行爬缓坡时出现气短
2 级	由于气短，平地行走时比同龄人慢或者需要停下来休息
3 级	在平地行走 100m 或者数分钟后需要停下来喘气
4 级	因为严重呼吸困难而不能离开家或者穿衣服时出现呼吸困难

NOTES

表 19-4 慢阻肺病患者自我评估测试问卷

我从不咳嗽	1	2	3	4	5	6	我总是在咳嗽
我一点痰也没有	1	2	3	4	5	6	我有很多很多痰
我没有任何胸闷的感觉	1	2	3	4	5	6	我有很严重的胸闷的感觉
当我爬坡或者上一层楼时，没有气喘感觉	1	2	3	4	5	6	当我爬坡或者上一层楼梯感觉严重喘不过气
我在家里能做任何事情	1	2	3	4	5	6	我在家里做任何事情均受影响
尽管我有肺部疾病，但对外出很有信心	1	2	3	4	5	6	由于我有肺部疾病，对离开家一点信心都没有
我的睡眠很好	1	2	3	4	5	6	由于我有肺部疾病，睡眠相当差
我精力旺盛	1	2	3	4	5	6	我一点精力都没有

注：数字 1~6 表示严重程度，请标记最能反映你当前情况的选项，在数字上打×，每个问题只能标记一个选项。

（三）综合评估

根据评估情况，可将慢阻肺病患者分为 A、B、E 组，见表 19-5。

表 19-5 慢阻肺病的综合评估

组别	特征		肺功能分级/级	急性加重/(次/年)	CAT 评分/分	呼吸困难分级/级
	风险	症状				
A 组	低	少	Ⅰ~Ⅱ	<2	<10	<2
B 组	低	多	Ⅰ~Ⅱ	<2	≥10	≥2
E 组	高	少	Ⅲ~Ⅳ	≥2	<10	<2
	高	多	Ⅲ~Ⅳ	≥2	≥10	≥2

在对慢阻肺病患者进行病情严重程度的综合评估时，还应注意有些合并症的症状与慢阻肺病类似，可能被忽略，需要认真识别。慢阻肺病常见的合并症有心血管疾病（如缺血性心脏病、心力衰竭、心房颤动、高血压、外周血管疾病）、骨质疏松症、焦虑/抑郁、睡眠呼吸暂停综合征、恶性肿瘤、代谢综合征、糖尿病、胃食管反流等，治疗时应予以兼顾。

临床病例（续）

初步评估（A）：

该患者行 CAT 评分为 24 分，mMRC 呼吸困难分级为 2 级。

结合患者老年男性，长期大量吸烟史。反复咳嗽、咳痰 10 余年，1 年来出现逐渐加重的呼吸困难。肺功能检查吸入支气管扩张剂后 $FEV_1/FVC<70\%$，可确定存在持续性气流受限，吸入支气管扩张剂后，FEV_1 占预计值 49.9%，肺功能损害明显，胸部 X 线检查可除外其他相关疾病，考虑患者慢性阻塞性肺疾病稳定期 GOLD 2 级 B 组。

【问题 6】该患者在社区如何进行长期管理？

思路 1：确定管理目标。对于稳定期慢阻肺病患者，管理目标主要基于症状和未来急性加重风险：①减轻当前症状：包括缓解呼吸系统症状、改善运动耐量和健康状况；②降低未来风险：包括防止疾病进展、防治急性加重及减少病死率。全科医生一旦确诊慢阻肺病患者，应当基于目前症状和对未

来急性加重风险的评估，为患者制订个体化的整体治疗方案，应发挥全科医生的优势以及全科团队的力量，不局限于药物治疗，使用适当的非药物干预措施加以补充。

思路 2：确定防治策略、预防措施、治疗方案。

思路 3：病情变化时及时转诊。

知识点

慢阻肺病社区防治

（一）防治策略

全科医生在社区为慢阻肺病患者个人及其家庭提供连续性、综合性、协调性、个体化和人性化的医疗服务，在慢阻肺病的不同阶段对人群开展疾病的预防。在慢阻肺病的三级预防中，都需要全科医生的参与。慢阻肺病在社区的防治应充分发挥团队服务的作用，根据病情进行分级管理，引导患者合理就医和规范诊疗，减轻症状和减少急性加重发生，提高生活质量。

1. 以人为中心　全科医生的管理应以减轻慢阻肺病患者当前症状、降低未来风险为目标，在此基础上提供戒烟咨询、疫苗接种推荐和肺康复等综合管理内容，提供连续性、综合性服务。

2. 以家庭为单位　须关注慢阻肺病患者所在家庭中一级亲属是否存在慢阻肺病，与其同居的家庭成员是否吸烟，日常生活中是否使用生物燃料，有无严重的室内空气污染，家庭经济条件情况，家庭成员的营养状态以及受教育程度，这些因素直接或间接影响着慢阻肺病患者的诊断、治疗和长期管理。

3. 以社区为范围　在社区层面开展慢阻肺病高危人群筛查，对辖区居民开展慢阻肺病相关知识宣教，提高慢阻肺病知晓率，开展控烟行动，减少吸烟及二手烟对辖区居民健康的损害，充分普及疫苗知识，提升流感疫苗和肺炎链球菌疫苗的接种率，特别是提高慢阻肺病患者和有慢性呼吸系统疾病的老年人的疫苗接种率。

（二）预防措施

1. 慢阻肺病的一级预防

（1）戒烟：可在最大程度上影响慢阻肺病的自然病程，也是慢阻肺病一级预防中最重要的方面。

（2）禁烟：减少二手烟的暴露也是慢阻肺病一级预防的环节之一。通过一系列综合性的控烟政策与措施，建立无烟学校，公共场所禁止吸烟，鼓励患者不在家中吸烟，可显著减少吸烟带来的相关危害。全科医生具有社区导向的岗位胜任力，也使其在禁烟过程中发挥相应作用。

（3）控制危险因素：全科医生在一级预防的过程中应建议高危人群减少职业性粉尘及有害化学物质暴露，加强室内外空气污染治理。

2. 慢阻肺病的二级预防　慢阻肺病的二级预防主要包括早期诊断、戒烟以及免疫治疗三个方面。全科医生在识别慢阻肺病的高危人群后，无论有无慢阻肺病症状，都应进行肺功能的检查。戒烟是慢阻肺病二级预防中最主要、最关键的措施。免疫治疗包括流感疫苗及肺炎链球菌疫苗接种，可预防并减少急性加重。接种流感疫苗可降低慢阻肺病患者严重疾病（如需要住院的下呼吸道感染）和死亡的发生率。建议所有≥65 岁的患者接种肺炎链球菌（PCV13 和 PPSV23）疫苗，也有建议有明显合并症（慢性心脏病或肺疾病）的较年轻的慢阻肺病患者接种 PPSV23 疫苗。

3. 慢阻肺病的三级预防　对于已经诊断为慢阻肺病的患者，三级预防的目的在于减少疾病对人体功能和生活质量的影响。在全科医生层面，对于慢阻肺病的长期随访管理也是三级预防的过程。其中包括：继续强化戒烟；重视慢阻肺病稳定期的长期药物治疗；加强慢阻肺病患者康复锻炼；对严重低氧者进行长程家庭氧疗；接种流感疫苗、肺炎链球菌疫苗，减少呼吸道感染；对慢阻肺病患者及其家庭成员进行健康教育；对慢阻肺病患者进行长期系统管理。

（三）治疗方案

1. 非药物治疗　非药物治疗是稳定期慢阻肺病治疗的重要组成部分，与药物治疗起到协同作用，包括：患者管理、呼吸康复治疗、家庭氧疗、家庭无创通气、疫苗、气道内介入、外科治疗等。

2. 药物治疗　慢阻肺病稳定期治疗药物如下。

（1）支气管扩张剂：是慢阻肺病的基础一线治疗药物，与口服药物相比，吸入制剂的疗效和安全性更优，因此多首选吸入治疗。主要的支气管扩张剂有 β_2 受体激动剂、抗胆碱药物及甲基黄嘌呤类药物（茶碱类药物），可根据药物作用及患者的治疗反应选用。

（2）吸入型糖皮质激素（ICS）：慢阻肺病稳定期长期单一应用 ICS 治疗并不能阻止 FEV_1 的降低趋势，对病死率亦无明显改善，因此不推荐对稳定期慢阻肺病患者使用单一 ICS 治疗。在使用 1 种或 2 种长效支气管扩张剂的基础上可以考虑联合 ICS 治疗。

（3）磷酸二酯酶-4（PDE-4）抑制剂：其主要作用是通过抑制细胞内环腺苷酸降解来减轻炎症，目前临床应用的是选择性 PDE-4 抑制剂罗氟司特，口服罗氟司特，每日 1 次，可改善应用沙美特罗或噻托溴铵治疗患者的 FEV_1，同时对于固定剂量 ICS+LABA（长效 β_2 受体激动剂）控制不佳的患者，加用罗氟司特对肺功能也有改善。

（4）其他药物：①祛痰药及抗氧化剂；②免疫调节剂；③中医治疗；④α_1-抗胰蛋白酶强化治疗。

当慢阻肺病出现急性加重期时，除上述药物，还可使用以下药物。

（1）抗生素：由于多数慢阻肺病急性加重是由细菌感染诱发，故抗生素在慢阻肺病急性加重治疗中具有重要地位。慢阻肺病急性加重患者如果存在呼吸困难加重、痰量增多和脓性痰这三个基本症状；或含脓性痰增多在内的两个基本症状；或需要有创或无创机械通气治疗，就应该接受抗生素治疗。推荐的抗生素的使用疗程为 5~7 天。

（2）糖皮质激素：慢阻肺病急性加重期住院患者宜在应用支气管扩张剂基础上全身应用糖皮质激素（简称“激素”），以缩短康复时间，改善肺功能和低氧血症，降低早期复发及治疗失败的风险，缩短住院时间。推荐应用泼尼松每天 40mg 治疗 5 天。

（四）基层转诊

分级诊疗是我国医疗管理的发展方向。不同级别医疗机构在慢阻肺病的分级诊疗中承担不同任务。基层医疗卫生机构主要进行慢阻肺病预防、高危及疑似患者的识别和筛查、患者教育、康复治疗和长期随访等。二级及以上医院主要进行慢阻肺病确诊、患者综合评估、戒烟干预、稳定期规范管理和治疗方案制订、急性加重期诊治、疑难危重症诊治等。

紧急转诊：当慢阻肺病患者出现中重度急性加重，经过紧急处理后症状无明显缓解，需要住院或行机械通气治疗，应考虑紧急转诊。

转诊前处理：当怀疑慢阻肺病患者出现中重度急性加重须紧急转诊时，转诊前须采取吸氧、开放静脉通路、持续心电监测、给予支气管扩张剂，并提前联系转诊医疗机构，沟通患者病情。

普通转诊：①因确诊或随访需求或条件所限，需要做肺功能等检查；②经过规范化治疗症状控制不理想，仍有频繁急性加重；③为评价慢阻肺病合并症或并发症，需要做进一步检查或治疗。

临床病例（续）

处置计划（P）：

（1）建立健康档案：建立随访记录表，纳入社区长期健康管理。

（2）健康教育：使患者了解慢性阻塞性肺疾病的相关知识，掌握一般和特殊的自我管理方法（如

吸入装置的使用、规律服药等，定期复诊及紧急情况下求救能力），社区医生定期随访。

（3）相关危险因素干预：让患者了解吸烟、室内外空气污染与慢性阻塞性肺疾病的关系，督促患者戒烟。

（4）药物治疗：雾化吸入噻托溴铵18μg，每日1次；雾化吸入沙美特罗替卡松50/250μg，每日2次。

（5）康复治疗：病情稳定后鼓励患者可通过适当咳嗽、呼吸及体育锻炼，增加呼吸功能，改善生活质量。①咳嗽和排痰；②缩唇呼吸和腹式呼吸；③扩胸、步行和骑车等运动。

（6）心理疏导：慢阻肺病患者因长期患病，影响日常生活，易出现焦虑、抑郁、猜疑、恐惧、悲观、失望等不良心理，针对病情及心理特征及时给予心理疏导，帮助患者树立战胜疾病的信心。

在慢阻肺病的随访过程中，全科医生首先要对患者慢阻肺病本身进行评估，询问症状变化、是否有急性加重，必要时转诊。同时了解患者药物的使用情况及依从性。患者合并有高血压，在高血压的慢性病管理过程中也应注意药物使用情况，避免使用β受体拮抗剂等与慢阻肺病治疗相矛盾的药物，协调患者整体用药情况。全科医生还应关注患者的经济能力及行动情况，以及对患者近期的心理状况予以评估。鼓励患者戒烟，并且提供相关帮助，必要时可转诊至戒烟门诊就诊。向患者提供肺康复相关的健康教育，对运动方式及运动时间作出具体指导，并建议患者注射流感疫苗及肺炎链球菌疫苗。

对于稳定期的慢阻肺病患者，基层管理过程中全科医生应充分发挥团队服务的作用，根据患者的肺功能、症状和既往急性加重情况进行分级管理。目的在于指导慢阻肺病患者合理就医和规范治疗，减轻呼吸道症状，减少疾病急性加重发生，预防、监测并积极治疗并发症，延缓肺功能的下降，提高生活质量。对于初诊的慢阻肺病患者首先应建立相关健康档案。根据其既往史、现病史、个人史、住院期间治疗情况、目前的治疗方案等资料为其建立标准化的个体健康档案，建立随访记录表，纳入社区长期健康管理。

（崔丽萍）

思考题

1. 在社区应该对哪些人群进行慢性阻塞性肺疾病的筛查？
2. 慢性阻塞性肺疾病稳定期和急性加重期的治疗原则分别是什么？
3. 如何从一级预防、二级预防、三级预防三个层面在社区对慢性阻塞性肺疾病进行预防？

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图